

Какова картина белой крови при остром лимфобластном лейкозе: {

~ лимфобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево, тени Боткина-Гумпрехта

= лимфобласты до 30%, лейкомический провал

~ миелобласты до 70-80%, лейкомический провал

~ миелобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, базофильно-

эозинофильная ассоциация

~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, выраженный моноцитоз,

единичные монобласты

}

Какова картина белой крови при хроническом лимфолейкозе: {

= лимфобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево, тени Боткина-Гумпрехта

~ лимфобласты до 30%, лейкомический провал

~ миелобласты до 70-80%, лейкомический провал

~ миелобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, базофильно-

эозинофильная ассоциация

~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, выраженный моноцитоз,

единичные монобласты

}

Какова картина белой крови при остром миелолейкозе: {

~ лимфобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево

~ лимфобласты до 30%, лейкомический провал

= миелобласты до 70-80%, лейкомический провал, лимфоцитопения, моноцитопения

~ миелобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, базофильно-

эозинофильная ассоциация

~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, выраженный моноцитоз,

единичные монобласты

}

Какова картина белой крови при хроническом миелолейкозе: {

~ лимфобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево

~ лимфобласты до 30%, лейкомический провал

~ миелобласты до 70-80%, лейкомический провал

= миелобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, базофильно-эозинофильная ассоциация
~ умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, выраженный моноцитоз, единичные монобласты
}

Какой вид обмена резко повышен при лейкозах, особенно при миелоидном: {
~ углеводный
~ жировой
~ минеральный
~ белковый
= пуриновый
}

Какие клетки появляются в крови при ретикулезе: {
= ретикулярные клетки и монобласты
~ лимфоциты
~ ретикулоциты и мегалоциты
~ моноциты и ретикулоциты
~ миелобласты и миелоциты
}

Как изменяется свертывание крови при лейкозах: {
~ повышается
~ незначительно понижается
= понижается
}

Какое изменение в нейтрофилах можно считать проявлением их дегенерации
~ наличие в цитоплазме пылевидной зернистости: {
= пикноз, фрагментоз ядра
~ палочковидное ядро
~ подковообразное ядро
~ наличие четырех сегментов в ядре
}

Какое изменение в периферической крови может отражать ядерный сдвиг нейтрофилов вправо: {

- ~ увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов
- ~ увеличение метамиелоцитов
- ~ появление миелоцитов
- ~ базофилия
- = гиперсегментация ядер нейтрофилов

}

О чем свидетельствует ядерный сдвиг нейтрофилов вправо: {

- ~ об омоложении клеток нейтрофильного ряда
- ~ о дегенерации нейтрофилов
- = о старении клеток
- ~ об уменьшении количества сегментоядерных нейтрофилов

}

Укажите причину, которая может привести к сдвигу лейкоцитарной формулы вправо: {

- = радиоактивные воздействия
- ~ действие высоких температур
- ~ понижение напряжения O₂ во вдыхаемом воздухе
- ~ действие кислот, щелочей на организм
- ~ глистные инвазии

}

Количество эритроцитов при болезни Вакеза: {

- ~ от 2 до 5 млн. в 1 куб. мм крови
- ~ от 5 до 6 млн. в 1 куб. мм крови
- ~ от 6 до 7 млн. в 1 куб. мм крови
- ~ от 7 до 8 млн. в 1 куб. мм крови
- = от 8 и более млн. в 1 куб. мм крови

}

При агранулоцитозе противoinфекционная устойчивость организма: {

- ~ повышена
- = понижена
- ~ не изменена
- ~ незначительно повышена
- ~ незначительно снижена

}

Укажите, какое заболевание сопровождается развитием абсолютной лимфоцитопении: {

- ~ инфекционный мононуклеоз
 - ~ иммунная форма агранулоцитоза
 - = острая лучевая болезнь
 - ~ гипопластическая анемия
 - ~ туберкулез
- }

Какое состояние сопровождается развитием абсолютной лимфопении: {

- ~ инфекционный мононуклеоз
 - ~ иммунная форма агранулоцитоза
 - = острая лучевая болезнь
 - ~ гипопластическая анемия
 - ~ туберкулез
- }

Какое состояние сопровождается развитием абсолютной нейтропении: {

- ~ острый инфаркт миокарда
 - = острая лучевая болезнь
 - ~ анемия Аддисона-Бирмера
 - ~ стрессовые состояния
 - ~ острый аппендицит
- }

Какое заболевание сопровождается абсолютной нейтрофилией: {

- = воспаление легких
 - ~ хронический лимфолейкоз
 - ~ туберкулез легких
 - ~ болезнь Иценко-Кушинга
 - ~ анемия
- }

Какое изменение в периферической крови отмечается при нейтрофильном лейкоцитозе: {

- ~ уменьшение процентного содержания лимфоцитов
 - ~ появление полисегментированных нейтрофилов
 - ~ увеличение процентного содержания моноцитов
 - ~ увеличение содержания лимфоцитов
 - = увеличение процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов
- }

Каков цветной показатель при злокачественной анемии: {

~ 0,5 - 0,6

~ 0,7 - 0,8
~ 0,9 - 1,0
= 1,2 - 1,3
~ 0,3 - 0,4
}

Процент гемоглобина при пернициозной анемии: {
= резко снижен
~ умеренно снижен
~ в пределах нормы
~ увеличен
~ резко увеличен
}

Изменения белой крови при пернициозной анемии: {
~ лейкоцитоз
= лейкопения, гиперсегментация нейтрофилов
~ лимфопения
~ эозинофилия
~ моноцитоз
}

Какая анемия возникает при дефиците внутреннего фактора Кастла: {
~ железодефицитная
~ энзимдефицитная
= B12 - дефицитная
~ белководефицитная
~ гемолитическая
}

Каков цветной показатель при злокачественной анемии: {
~ 0,5 - 0,6
~ 0,7 - 0,8
~ 0,9 - 1,0
= 1,2 - 1,3
~ 0,3 - 0,4
}

Процент гемоглобина при пернициозной анемии: {
= резко снижен
~ умеренно снижен
~ в пределах нормы

- ~увеличен
- ~резко увеличен

}

Изменения белой крови при пернициозной анемии: {

- ~лейкоцитоз
- =лейкопения, гиперсегментация нейтрофилов
- ~лимфопения
- ~эозинофилия
- ~моноцитоз

}

Какая анемия возникает при дефиците внутреннего фактора Кастла: {

- ~железодефицитная
- ~энзимдефицитная
- =B12 - дефицитная
- ~белководефицитная
- ~гемолитическая

}

При каком состоянии наблюдается уменьшение показателя гематокрита: {

- ~при снижении содержания в эритроцитах 2,3 - дифосфоглицерата
- ~в течение первого часа после острой кровопотери
- =через 4-5 суток после острой кровопотери
- ~при неукротимой рвоте
- ~при ожоговом шоке

}

Укажите, какое изменение гематологических показателей характерно для острой постгеморрагической анемии (на 7-е сутки): {

- ~анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов
- ~тромбоцитопения
- ~нейтропения
- ~гипербилирубинемия
- =ретикулоцитоз

}

Сразу после острой кровопотери возникает: {

- ~олигоцитемическая гиповолемия
- ~полицитемическая гиповолемия
- =простая гиповолемия

~олигоцитемическая нормоволения
~полицитемическая нормоволения
}

К каким видам анемий относится острая постгеморрагическая анемия по типу кроветворения: {
=к регенеративным
~к арегенеративным
~к дегенеративным
~к регенеративным
~к эмбриональным
}

Изменения эритроцитов при острой постгеморрагической анемии на пятые сутки {
~макроциты, мегалоциты, нормобласты
~ретикулоциты, мегалобласты, полихроматофилия
~анизоцитоз, микро- макроциты
=полихроматофилия, гипохромия, ретикулоцитоз, нормобласты
~полихроматофилия, анизо-пойкилоцитоз, микроциты
}

Каков цветной показатель в начальном периоде острой постгеморрагической анемии: {
=в пределах нормы
~больше единицы
~меньше единицы
~резко уменьшен
~резко увеличен
}

Каков цвет кожных покровов при гипохромной анемии: {
~синюшный
~желтушный
=бледный
~не изменен
}

Количество эритроцитов при позднем хлорозе: {
~увеличено
=уменьшено
~существенно не изменено
~резко увеличено
~резко уменьшено

}

К какому виду анемий относится хлороз: {

~к постгеморрагической

~к гемолитической

=к железодефицитной

~к анемии вследствие дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты

~к гемоглобинозам

}

Каков ведущий механизм нарушений функций организма при анемиях: {

~полицитемическая гиповолемия

=гемическая гипоксия

~циркуляторная гипоксия

~олигоцитемическая гиперволемия

~олигоцитемическая гиповолемия

}

Незрелые клетки, содержащие гемоглобин - это: {

~эритробласты

~нормобласты базофильные

~проэритробласты

=нормобласты ортохромные

~ретикулоциты

}

Какой эритроцит содержит больше гемоглобина: {

~макроцит

~микроцит

~полихроматофил

~нормоцит

=мегалоцит

}

Анизоцитоз. Определение понятия: {

~различная форма клеток

=различная величина клеток

~наличие зерен и нитей в эритроцитах

~способность окрашиваться кислой и основной краской

~появление ядерных форм эритроцитов

}

Как называется различная форма эритроцитов: {

- ~анизоцитоз
- ~полихроматофилия
- ~микроцитоз
- ~макро-мегалоцитоз
- =пойкилоцитоз

}

Дегенеративные формы эритроцитов: {

- =анизоцитоз, пойкилоцитоз
- ~полихроматофилия, анизоцитоз
- ~микроцитоз, ретикулоциты
- ~нормобласт, эритробласт
- ~пронормобласт, ретикулоциты

}

Анемия. Определение понятия: {

- ~малокровие
- ~уменьшение эритроцитов в единице объема
- ~уменьшение гемоглобина в крови
- =уменьшение гемоглобина, эритроцитов и качественные изменения эритроцитов
- ~нет правильных вариантов

}

Какой вид анемии относится к регенеративному типу: {

- ~ хлороз
- = постгеморрагическая анемия
- ~железодефицитная анемия
- ~ пернициозная анемия
- ~ белководефицитная анемия

}

Укажите причину гипохромных анемий: {

- ~ недостаток витаминов В12
- ~ расстройство обмена белка
- ~ нарушение функции костного мозга
- = нарушение обмена железа
- ~ усиленный распад эритроцитов

}

Как изменяются гемодинамические показатели в ближайшие минуты после острой кровопотери: {

= уменьшается ОЦК, снижается минутный объем сердца

~уменьшается ОЦК, повышается минутный объем сердца

~уменьшается ОЦК, повышается тонус резистивных сосудов

~снижается минутный объем сердца, повышается тонус резистивных сосудов мозга

~повышается минутный объем сердца, снижается тонус резистивных сосудов мозга

}

В каком случае возникает полицитемическая гиперволемиа: {

~ при переливании большого количества крови

~ у пациентов с заболеваниями почек

~ при спадении отеков

= у пациентов с болезнью Вакеза

~ при парентеральном введении кровезаменителей

}1

Укажите интервал времени, в течение которого обычно восстанавливается ОЦК (при потере 1000мл) за счет поступления в сосуды тканевой жидкости: {

~1-2ч.

= 1-2 сут.

~2-3 сут.

~4-5 сут.

~7-8 сут.

}

Укажите интервал времени, в течение которого обычно восстанавливается ОЦК (при потере 1000 мл)

за счет активации эритропоэза: {

~1-2 ч.

~1-2 сут.

~2-3 сут.

= 4-5 сут.

~7-8 сут.

}

Укажите нормальные показатели гематокрита взрослого человека: {

~ 0,40 - 0,55 Л/л крови

- ~0,45 - 0,65 Л/л крови
 - = 0,36 - 0,48 Л/л крови
 - ~ 0,32 - 0,52 Л/л крови
 - ~0,30 - 0,43 Л/л крови
- }

Что такое гематокритное число: {

- =это содержание эритроцитов в общем объеме крови
 - ~процентное отношение гемоглобина к процентному отношению эритроцитов
 - ~степень насыщения гемоглобина эритроцитов
 - ~отношение объема плазмы к общему объему крови
 - ~нет правильного ответа
- }

Для гемолитической анемии характерна: {

- ~олигоцитемическая гиповолемия
 - ~олигоцитемическая гиперволемия
 - ~полицитемическая гиповолемия
 - =олигоцитемическая нормоволемия
 - ~полицитемическая нормоволемия
- }

Укажите фактор, имеющий приспособительное значение для организма в ближайшие минуты и часы после острой кровопотери: {

- ~уменьшение венозного возврата крови
 - ~тканевая гипоперфузия
 - =периферическая вазоконстрикция
 - ~брадикардия
 - ~гиповентиляция
- }

В каком случае возникает полицитемическая гиперволемия: {

- ~при переливании большого количества крови
- ~у пациентов с заболеваниями почек
- ~при спадении отеков
- =у пациентов с болезнью Вакеза
- ~при парентеральном введении кровезаменителей

}

Укажите интервал времени, в течение которого обычно восстанавливается ОЦК (при потере 1000 мл за счет активации эритропоэза: {

~1-2 ч.

~1-2 сут.

~2-3 сут.

=4-5 сут.

~7-8 сут.

}

Признаки эмбрионального эритропоэза: {

~ретикулоциты, полихроматофилы

=мегалобласты, мегалоциты, проэритробласты, нормобласты

~анизоцитоз, пойкилоцитоз

~мегалобласты, кольца Кабо, тельца Жолли

~тельца Жолли, полихроматофилы, аницитоз

}

Способность эритроцитов окрашиваться кислой и основной краской: {

=полихроматофилия

~анизоцитоз

~пойкилоцитоз

~гипохромия

~базофилия

}

Незрелые клетки, содержащие гемоглобин: {

~эритробласты

~нормобласты базофильные

~проэритробласты

=нормобласты ортохромные

~ретикулоциты

}

Какой эритроцит содержит больше гемоглобина: {

~макроцит

~микроцит

~полихроматофил
~нормоцит
=мегалоцит
}

Анизоцитоз. Определение понятия: {
~различная форма клеток
=различная величина клеток
~наличие зерен и нитей в эритроцитах
~способность окрашиваться кислой и основной краской
~появление ядерных форм эритроцитов
}

Как называется различная форма эритроцитов: {
~анизоцитоз
~полихроматофилия
~микроцитоз
~макро-мегалоцитоз
=пойкилоцитоз
}

Дегенеративные формы эритроцитов: {
=анизоцитоз, пойкилоцитоз
~полихроматофилия, анизоцитоз
~микроцитоз, ретикулоциты
~нормобласт, эритробласт
~пронормобласт, ретикулоциты
}

Анемия. Определение понятия: {
~малокровие
~уменьшение эритроцитов в единице объема
~уменьшение гемоглобина в крови
=уменьшение гемоглобина, эритроцитов и качественные изменения эритроцитов
~нет правильных вариантов
}

Какой вид анемии относится к регенеративному типу: {

~хлороз
=постгеморрагическая анемия
~железодефицитная анемия
~пернициозная анемия
~белководефицитная анемия
}

Укажите причину гипохромных анемий: {
~недостаток витаминов В12
~расстройство обмена белка
~нарушение функции костного мозга
=нарушение обмена железа
~усиленный распад эритроцитов
}

Каково содержание гемоглобина при гипохромной анемии: {
~умеренно уменьшается
~увеличивается
~существенно не изменяется
=резко уменьшается
~умеренно увеличивается
}

Каков кожный цвет кожных покровов при гипохромной анемии: {
~синюшный
~желтушный
=бледный
~не изменен
}

Количество эритроцитов при гипохромной анемии: {
~увеличено
~уменьшено
=существенно не изменено
~резко уменьшается
~резко увеличивается
}

Каков ведущий механизм нарушений функций организма при анемиях: {

~полицитемическая гиповолемия
=гемическая гипоксия
~циркуляторная гипоксия
~олигоцитемическая гиперволемия
~олигоцитемическая гиповолемия
}

Какую из перечисленных анемий можно отнести к гипорегенераторным: {
=хроническую постгеморрагическую анемию
~острую постгеморрагическую анемию
~геморрагическую анемию Минковского-Шоффара
~аутоиммунную гемолитическую анемию
~апластическую анемию
}

При какой анемии наблюдается мегалобластический тип кроветворения: {
~железодефицитная анемия
~острая постгеморрагическая анемия
~гемолитическая анемия
=В12 (фолиево) - дефицитные анемии
~гипопластическая анемия
}

Для какой анемии характерен микроцитоз эритроцитов {
~гипопластическая анемия
=железодефицитная анемия
~острая постгеморрагическая анемия
~фолиеводефицитная анемия
~талассемия
}

Какой фактор вызывает железодефицитную анемию: {
~дефицит внутреннего фактора слизистой оболочки желудка
~уменьшение продукции эритропоэтина
=повышение расходования железа
~массивный гемолиз эритроцитов
~дефицит витамина В12
}

Укажите, какие изменения гематологических показателей характерны для железодефицитной анемии: {

~содержание железа в сыворотке крови больше 15 ммоль/л

=анизоцитоз, пойкилоцитоз, выраженная гипохромия

~ретикулоцитоз до 15-20 %

~нейтрофилия

~гипербилирубинемия

}

Количество эритроцитов при позднем хлорозе: {

~увеличено

=уменьшено

~существенно не изменено

~резко увеличено

~резко уменьшено

}

К какому виду анемий относится хлороз: {

~к постгеморрагической

~к гемолитической

=к железодефицитной

~к анемии, вследствие дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты

~к гемоглобинозам

}

Каков основной патогенетический механизм хлороза: {

~кровотечение

~гемолиз эритроцитов

~нарушение созревания эритроцитов

~нарушение вымывания эритроцитов из костного мозга

=нарушение процесса гемоглобинообразования

}

К каким видам анемий относится острая постгеморрагическая анемия по типу кроветворения: {

=к регенеративным

~к арегенеративным

~к дегенеративным

~к регенеративным признакам регнераций

~к эмбриональным
}

Каков цветной показатель в начальном периоде острой постгеморрагической анемии: {

=в пределах нормы
~больше единицы
~меньше единицы
~резко уменьшен
~резко увеличен
}

Каков цветной показатель в поздний период острой кровопотери: {

~в пределах нормы
=меньше единицы
~больше единицы
~резко уменьшен
~резко увеличен
}

Какое состояние может вызывать повышение выработки эритропоэтина: {

~повышенное насыщение крови кислородом
~увеличение содержания Нв в крови
~наследственное нарушение синтеза нормального Нв
=кровопотеря
~гипоксия миелоидной ткани
}

При каком состоянии наблюдается простая гиповолемия: {

=через 30-40 мин: { после острой кровопотери
~через 24-48 ч: { после острой кровопотери
~при ожоговом шоке
~при перегревании организма
~ при митральном пороке
}

Укажите, какое изменение гематологических показателей характерно для острой постгеморрагической анемии (на 7-е сутки): {

~анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов

~тромбоцитопения
~нейтропения
~гипербилирубинемия
=ретикулоцитоз
}

Сразу после острой кровопотери возникает: {

~олигоцитемическая гиповолемия
~полицитемическая гиповолемия
=простая гиповолемия
~олигоцитемическая нормоволемия
~полицитемическая нормоволемия
}

Укажите причину гемолитической анемии: {

~внутривенное дробное введение гипертонических растворов
=действие фенилгидразина
~массивные кровоизлияния
~дефицит внутреннего фактора Кастла
~гемофилия
}

Укажите, какой гематологический показатель характерен для острой гемолитической анемии: {

~выраженная гипохромия эритроцитов
~гипоплазия костного мозга
~лейкопения, тромбоцитопения
~отсутствие ретикулоцитов
=выраженный ретикулоцитоз
}

Как изменяется цветной показатель при гемолитической анемии в период криза: {

~равен единице
~больше единицы
~меньше единицы
=равен или больше единицы
~равен или меньше единицы
}

При каком виде анемии нарушен обмен витамина В12: {

~при хлорозе

=при мегалобластической

~при гемолитической

~при постгеморрагической

~при апластической

}

Назовите тип кроветворения при злокачественной анемии: {

~регенеративный

~арегенеративный

=мегалобластический

~апластический

~нормобластический

}

Каков цветной показатель при злокачественной анемии: {

~0,5 - 0,6

~0,7 - 0,8

~0,9 - 1,0

=1,2 - 1,3

~0,3 - 0,4

}

Процент гемоглобина при пернициозной анемии: {

=резко снижен

~умеренно снижен

~в пределах нормы

~увеличен

~резко увеличен

}

Изменения белой крови при пернициозной анемии: {

~лейкоцитоз

=лейкопения, гиперсегментация нейтрофилов

~лимфопения

~эозинофилия

~моноцитоз

}

Какая анемия возникает при дефиците внутреннего фактора Кастла: {

~железодефицитная

~энзимдефицитная

=B12 - дефицитная

~белководефицитная

~гемолитическая

}

Какое состояние может обусловить развитие мегалобластной анемии: {

=гельминтоз (широкий лентец)

~хроническая кровопотеря

~белковое голодание

~авитаминоз B6

~усиление гемолиза

}

Какое состояние может обусловить развитие мегалобластной анемии: {

=беременность

~хроническая кровопотеря

~белковое голодание

~авитаминоз B6

~усиление гемолиза

}

Повышенный цветовой показатель обнаруживается при: {

~наследственных гемолитических анемиях вне кризиса

~гипопластической анемии

=анемии Аддисона-Бирмера

~железодефицитной анемии

~острой постгеморрагической анемии

}

Укажите причину гипопластической анемии: {

~резекция желудка

=ионизирующая радиация

~недостаток в пище витамина B12

~перегревание организма

~сердечная недостаточность
}

Какой гематологический показатель характерен для гипопластической анемии: {

=Панцитопения
~Гипохромия эритроцитов
~Ретикулоцитоз
~Гиперплазия костного мозга
~Нормобластический тип кроветворения
}

Назовите анемию, протекающую с отсутствием в костном мозге эритробластов и в периферической крови ретикулоцитов: {

~гипорегенераторная
~гипопластическая
=апластическая
~арегенераторная
~белководефицитная
}

Укажите причину эритроцитоза: {

~Кессонная болезнь
~Гиперволемия
~Талассемия
~Все верно
=Гипобарическая гипоксия
}

Какое состояние сопровождается развитием абсолютного эритроцитоза: {

=Болезнь Вакеза
~Метаболическая анемия
~лимфома
~Гемодилюция
~Гемоконцентрация
}

Какое состояние сопровождается развитием абсолютного эритроцитоза: {

~Мегалобластная анемия

=Хроническая гипоксия
~Болезнь Верльгофа
~Ишемия почек
~Гемодилюция
}

При какой анемии развиваются воспалительно-атрофические процессы в слизистой оболочке пищевого канала: {

~гемолитической
~железодефицитной
~белководефицитной
=пернициозной
~гипопластической
}

При какой анемии развивается фуникулярный миелоз: {

~гемолитический
~железодефицитной
~белководефицитной
=пернициозной
~гипопластической
}

У какой клинической формы анемий возникает наследственный дефект первичной структуры цепей глобина: {

~альфа-талассемия
~бета-талассемия
=серповидноклеточная анемия
~микросфероцитарная анемия
~все верно
}

При какой анемии в крови наблюдается мишеневидные или базофильно-пунктированные эритроциты: {

~токсикогемолитической
~серповидноклеточной
=талассемии
~болезни Минковского-Шоффара
~B12-дефицитной: {

}

К каким клиническим формам относится наследственная мембранопатия: {

~глюкозо- 6 фосфатдегидрогеназная анемия

=микросфероцитарная гемолитическая анемия

~альфа-талассемия

~бета-талассемия

~серповидноклеточная анемия

}

Как изменяется общий объем крови при физической работе: {

~возникает гиперволемиа олигоцитемическая

=возникает простая гиперволемиа

~возникает полицитемическая гиперволемиа

~практически не меняется

~возникает нормоволемиа полицитемическая

}

Что является показателем зрелости лейкоцитов: {

~наличие зернистости

~интенсивность окраски цитоплазмы

=степень сегментации ядра

~отсутствие зерен в цитоплазме

~отсутствие сегментации

}

Что понимают под термином "агранулоцитоз": {

~резкое уменьшение лейкоцитов

=резкое уменьшение зернистых лейкоцитов

~резкое уменьшение лимфоцитов

~резкое уменьшение эритроцитов

~перераспределение лейкоцитов

}

При каком заболевании возникает гранулоцитопения (агранулоцитоз): {

=при лекарственной аллергии и лучевой болезни

~при стрепто-стафилококковых инфекциях

~при хронических инфекциях

~при острых инфекциях

~при вирусных инфекциях
}

Какие функции выполняют нейтрофилы: {

~антителообразования
~являются хелперами в иммунном ответе
~нейтрализуют токсические вещества
=участвуют в метаболических тканевых процессах
~завершают воспалительную реакцию
}

Укажите механизм развития лейкоцитозов: {

~подавление лейкопоэза
~усиленное разрушение лейкоцитов
=активация лейкопоэза
~повышенный выход лейкоцитов в ткани
~увеличение продукции лейкопоэтина
}

Лейкоцитарная формула при физиологическом лейкоцитозе: {

=не изменяется
~незначительно изменяется
~резко изменяется за счет нейтрофилов
~увеличивается процент лимфоцитов
~появляется базофильно-эозинофильная ассоциация
}

Каков механизм физиологического лейкоцитоза: {

~усиление лейкопоэза
=перераспределение лейкоцитов
~понижение физиологического разрушение лейкоцитов
~мобилизация костномозгового резерва без активации лейкопоэза
~выброс из депо
}

При каком заболевании наблюдается базофильный лейкоцитоз: {

~при воспалении
~при сенной лихорадке
=при миелоидном лейкозе

- ~при скарлатине
- ~при туберкулезе

}

Что значит "сдвиг ядра нейтрофилов влево": {

- ~увеличение эозинофилов
- ~увеличение агранулоцитов
- =увеличение нейтрофилов с несегментированным ядром
- ~появление гиперсегментации ядра
- ~увеличение базофилов

}

Какова причина сдвига ядра нейтрофилов влево: {

- ~действие токсических веществ
- =раздражение и повышенная реактивность костного мозга
- ~радиоактивные излучения
- ~хронические инфекции
- ~все перечисленное

}

Что значит "дегенеративный сдвиг ядра нейтрофилов влево": {

- ~увеличение всех несегментированных форм
- ~увеличение эозинофилов
- ~увеличение агранулоцитов
- ~увеличение базофилов
- =увеличение только палочкоядерных

}

Укажите причину сдвига ядра нейтрофилов вправо: {

- ~увеличение патологических форм
- =появление гиперсегментации и увеличение сегментоядерных форм
- ~увеличение лимфоцитов
- ~увеличение моноцитов
- ~увеличение всех форм гранулоцитов

}

Укажите механизм возникновения лейкопений: {

- ~активация лейкопоэза
- ~увеличение продукции лейкопоэтина

~уменьшение продукции эритропоэтина
=подавление лейкопоэза
~мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов
}

Какое заболевание сопровождается эозинофилией? {
~хронический лимфолейкоз
~бактериальная пневмония
~корь
=паразитарное
~эритремия
}

Укажите механизм возникновения лейкопений: {
~активация лейкопоэза
~увеличение продукции лейкопоэтина
~уменьшение продукции эритропоэтина
=нарушение созревания в костном мозге
~мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов
}

Укажите механизм возникновения истинного лейкоцитоза: {
~мобилизация костномозгового резерва без активации лейкопоэза
~замедленное разрушение лейкоцитов
~повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
=активация лейкопоэза
~гемоконцентрация
}

Укажите механизм возникновения истинной лейкопении: {
=угнетение лейкопоэза
~повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
~недостаточная мобилизация костно-мозгового резерва лейкоцитов
~активация лейкопоэза
~увеличение продукции эритропоэтина
}

При агранулоцитозе противоинфекционная устойчивость организма: {
~повышена

=понижена
~не изменена
~незначительно повышена
~незначительно снижена
}

Укажите, какое заболевание сопровождается развитием абсолютной лимфоцитопении? {

~инфекционный мононуклеоз
~иммунная форма агранулоцитоза
=острая лучевая болезнь
~гипопластическая анемия
~туберкулез
}

Какое состояние сопровождается развитием абсолютной лимфоцитопении: {

~инфекционный мононуклеоз
~иммунная форма агранулоцитоза
=острая лучевая болезнь
~гипопластическая анемия
~туберкулез
}

Какое состояние сопровождается развитием абсолютной нейтропении: {

~острый инфаркт миокарда
=острая лучевая болезнь
~анемия Аддисона-Бирмера
~стрессовые состояния
~острый аппендицит
}

Какое заболевание сопровождается абсолютной нейтрофилией: {

=воспаление легких
~хронический лимфолейкоз
~брюшной тиф
~туберкулез легких
~Болезнь Иценко-Кушинга
}

Какое изменение в нейтрофилах можно считать проявлением их дегенерации: {

~наличие в цитоплазме пылевидной зернистости

=пикноз, фрагментоз ядра

~палочковидное ядро

~подковообразное ядро

~наличие четырех сегментов в ядре

}

Какое изменение в периферической крови может отражать ядерный сдвиг нейтрофилов вправо? {

~увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов

~увеличение метамиелоцитов

~появление миелоцитов

~базофилия

=гиперсегментация ядер нейтрофилов

}

О чем свидетельствует ядерный сдвиг нейтрофилов вправо: {

~об омоложении клеток нейтрофильного ряда

~о дегенерации нейтрофилов

~о гипосегментации ядер нейтрофилов

=о старении клеток

~об уменьшении количества сегментоядерных нейтрофилов

}

Укажите причину, которая может привести к сдвигу лейкоцитарной формулы вправо: {

=радиоактивные воздействия

~действие высоких температур

~понижение напряжения O₂ во вдыхаемом воздухе

~действие кислот, щелочей на организм

~глистные инвазии

}

Какова картина крови при нейтрофильном лейкоцитозе с гипорегенеративным сдвигом: {

~увеличение палочкоядерных, юных, появление миелоцитов

~увеличение палочкоядерных, метамиелоцитов

=увеличение палочкоядерных нейтрофилов
~увеличение сегментоядерных нейтрофилов
~гиперсегментация ядер нейтрофилов
}

Какова картина крови при нейтрофильном лейкоцитозе с регенеративным сдвигом? {

~увеличение палочкоядерных, юных, появление миелоцитов: {
=увеличение палочкоядерных, метамиелоцитов
~увеличение палочкоядерных нейтрофилов
~увеличение сегментоядерных нейтрофилов
~гиперсегментация ядер нейтрофилов
}

Укажите, какое заболевание может сопровождаться нейтрофильным лейкоцитозом с регенеративным сдвигом: {

~ангина
=крупозная пневмония
~бронхиальная астма
~тяжелый перитонит
~краснуха
}

Какое заболевание может сопровождаться нейтрофильным лейкоцитозом с гиперрегенеративным сдвигом: {

=сепсис
~корь
~сывороточная болезнь
~туберкулез
~крапивница
}

Какова картина крови при лейкемоидной реакции миелоидного типа: {

~лейкопения, лимфоцитопения
~лейкоцитоз
=резкий лейкоцитоз, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево
~умеренный лейкоцитоз, появление бластных клеток, базофилия
~резкий лейкоцитоз, сдвиг формулы вправо

}

Отличие лейкомоидной реакции от лейкоза: {

~первичное поражение кроветворной ткани

~наличие базофильно-эозинофильной ассоциации

~сопровождается метаплазией, анаплазией ткани костного мозга

~носит длительный, затяжной характер

=носит временный, симптоматический характер

}

Какой из лейкозов чаще встречается в детском возрасте: {

=острый лимфобластный лейкоз

~хронический лимфолейкоз

~хронический миелолейкоз

~острый миелолейкоз

~хронический ретикулоэндотелиоз

}

Какова картина белой крови при хроническом лимфолейкозе: {

=лимфобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево, тени Боткина-Гумпрехта

~лимфобласты до 30%, лейкомический провал

~миелобласты до 70-80%, лейкомический провал

~миелобласты единичные, гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, базофильно-эозинофильная ассоциация: {

~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, выраженный моноцитоз, единичные монобласты

}

Какова картина белой крови при остром

Миелолейкозе: {

~лимфобласты

единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево

~лимфобласты до 30%, лейкомический провал

=миелобласты до 70-80%, лейкомический провал, лимфоцитопения, моноцитопения

~миелобласты единичные,

гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
базофильно-эозинофильная ассоциация
~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
выраженный моноцитоз, единичные монобласты
}

Какова картина белой крови при хроническом миелолейкозе: {
~лимфобласты
единичные, гиперрегенеративный сдвиг формулы влево
~лимфобласты до 30%, лейкемический провал
~миелобласты до 70-80%, лейкемический провал
=миелобласты единичные,
гиперрегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
базофильно-эозинофильная ассоциация
~умеренный лейкоцитоз, регенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
выраженный моноцитоз, единичные монобласты
}

Какой вид обмена резко повышен при лейкозах, особенно при миелоидном: {
~углеводный
~жировой
~минеральный
~белковый
=пуриновый
}

Какие клетки появляются в крови при ретикулезе: {
=ретикулярные клетки и монобласты

- ~лимфоциты
- ~ретикулоциты и мегалоциты
- ~моноциты и ретикулоциты
- ~миелобласты и миелоциты

}

Как изменяется свертывание крови при лейкозах: {

- ~повышается
- ~незначительно понижается
- =понижается
- ~не изменяется

}

Оглушенность миокарда - это состояние, вызванное: {

- =кратковременной и выраженной ишемией миокарда
- ~хронической гипоперфузией миокарда
- ~незначительной ишемией миокарда
- ~полным прекращением коронарного кровотока
- ~длительной и выраженной ишемией миокарда

}

Бездействующий миокард - это состояние, вызванное: {

- ~кратковременной и выраженной ишемией миокарда
- =хронической гипоперфузией миокарда
- ~незначительной ишемией миокарда
- ~полным прекращением коронарного кровотока
- ~длительной и выраженной ишемией миокарда

}

Чем обусловлена перегрузка миокарда в результате повышения сопротивления оттоку крови: {

- =стенозом устья аорты
- ~недостаточностью митрального клапана
- ~недостаточностью аортального клапана
- ~недостаточностью трикуспидального клапана
- ~артериальной гипотензией

}

Перегрузка миокарда увеличенным объемом крови может быть обусловлена: {

- ~стенозом устья аорты
 - ~легочной гипертензией
 - =регургитацией крови при недостаточности клапанов
 - ~артериальной гипертензией
 - ~системным атеросклерозом
- }

Аритмии вызывают: {

- =падение ударного объема сердца
 - ~повышение ударного объема сердца
 - ~снижение периферического сопротивления сосудов
 - ~повышение периферического сопротивления сосудов
 - ~все перечисленное
- }

Какие электрокардиографические изменения являются маркерами некроза миокарда? {

- ~удлинение интервала P-Q
 - =углубление зубца Q
 - ~изменение зубца P
 - ~отсутствие подъема сегмента S-T
 - ~уширение комплекса QRST
- }

Укажите факторы, состояния, которые могут вызывать сердечную недостаточность посредством прямого повреждения миокарда: {

- ~недостаточность трикуспидального клапана
 - ~гипертоническая болезнь
 - =септические состояния
 - ~стеноз устья аорты
 - ~недостаточность аортального клапана
- }

Гиперкалиемия вызывает: {

- =атриовентрикулярную блокаду проведения импульсов возбуждения
- ~артериальную гипертензию

- ~тахикардию
- ~мерцательную аритмию
- ~экстрасистолию

}

Какой частотой сердечных сокращений характеризуется пароксизмальная тахикардия: {

- ~сердечный ритм неправильный
- ~частота сердечных сокращений - 100 – 140 ударов в 1 минуту
- =частота сердечных сокращений - 140 – 250 ударов в 1 минуту
- ~частота сердечных сокращений - 250 – 300 ударов в 1 минуту
- ~частота сердечных сокращений – больше 300 ударов в 1 минуту

}

Чем характеризуется синусовая аритмия^ {

- =увеличением частоты сердечных сокращений на вдохе в норме
- ~увеличением частоты сердечных сокращений на выдохе
- ~уменьшением ЧСС на вдохе
- ~уменьшением ЧСС на выдохе
- ~тахикардией

}

Атриовентикулярная блокада первой степени характеризуется: {

- =удлинением интервала P - Q более 0,1 с.
- ~периодическим выпадением комплекса QRST на каждое 2-3 сокращение
- ~периодическим выпадением комплекса QRST на каждое 8-9 сокращение
- ~диссоциацией сокращений
- ~смещением интервала ST

}

Атриовентикулярная блокада второй степени характеризуется: {

- ~удлинением интервала P - Q до 0,21 с.
- =появлением периодов Венкебаха-Самойлова
- ~выпадением желудочкового комплекса на каждое 8-9 сокращение
- ~диссоциацией сокращений
- ~смещением интервала ST

}

Атриовентикулярная блокада третьей степени характеризуется: {

~удлинением интервала P - Q до 0,21 с: {
~появлением периодов Венкебаха-Самойлова
=выпадением желудочкового комплекса на каждое 3-6 сокращений
~диссоциацией сокращений
~смещением интервала ST
}

Атриовентрикулярная блокада четвертой степени характеризуется: {
~удлинением интервала P - Q до 0,21 с: {
~появлением периодов Венкебаха-Самойлова
~выпадением желудочкового комплекса на каждое 8-9 сокращение
=диссоциацией сокращений предсердий и желудочков
~смещением интервала ST
}

Какие химические вещества вызывают расширение коронарных сосудов при ишемии миокарда: {
~молочная кислота
~гистамин
~брадикинин
=аденозин
~CO₂
}

Какой ведущий механизм способствует развитию сердечных отеков: {
=снижение ударного и минутного объема крови
~увеличение минутного объема крови
~гиперволемия
~падение А/Д
~все ответы правильные
}

Какие состояния приводят к перегрузке миокарда сопротивлением оттоку крови: {
~недостаточность митрального клапана
~недостаточность аортального клапана
=артериальная гипертензия
~недостаточность клапанов правого атриовентрикулярного отверстия
~все ответы правильные

}

При каких состояниях включается гомеометрический механизм компенсации: {

~недостаточность митрального клапана

=стеноз митрального отверстия

~недостаточность аортального клапана

~недостаточность трикуспидального клапана

~недостаточность клапана легочной артерии

}

При каких состояниях включается гетерометрический механизм компенсации: {

~сужение устья аорты

~стеноз митрального клапана

=недостаточность митрального клапана

~гипертоническая болезнь

~сужение устья легочной артерии

}

При каких состояниях повышается напряжение мышечного волокна: {

~при недостаточности митрального клапана

=при стенозе устья аорты

~при недостаточности аортального клапана

~при недостаточности трикуспидального клапана

~при недостаточности клапана легочной артерии

}

Какие механизмы компенсации относятся к экстракардиальным: {

~концентрическая гипертрофия миокарда

~миогенная дилатация

~тахикардия

=снижение тонуса сосудов

~тоногенная дилатация

}

Проявления сердечной недостаточности: {

~уменьшение ОЦК

- =увеличение остаточного объема в полостях сердца
- ~увеличение скорости кровотока
- ~снижение давления в полостях сердца
- ~все перечисленное

}

При каких экстрасистолиях наблюдается удлинение компенсаторной паузы: {

- ~предсердиях
- ~атриовентрикулярных
- =желудочковых
- ~все перечисленное

}

При какой блокаде наблюдается диссоциация сокращений предсердий и желудочков: {

- ~синоаурикулярной
- =атриовентрикулярной 4 степени
- ~атриовентрикулярной 1 степени
- ~атриовентрикулярной 2 степени
- ~атриовентрикулярной 3 степени

}

ЭКГ признаки желудочковой экстрасистолии: {

- ~удлинение интервала P - Q
- ~смещение интервала ST ниже изолинии
- =изменение конфигурации желудочкового комплекса
- ~отрицательный зубец T
- ~глубокий зубец Q

}

Изменения в крови при инфаркте миокарда: {

- ~лекопения
- ~эритропения
- ~снижение СОЭ
- ~эритроцитоз
- =лейкоцитоз

}

Количество каких ферментов повышено в крови при инфаркте миокарда: {

~дастаза
=АСТ
~АЛТ
~щелочная фосфатаза
~альдолаза
}

Укажите возможные причины некоронарного некроза миокарда: {

~спазм венечных сосудов
~гемоконцентрация
=гиперпродукция стероидных гормонов
~тромбоцитопения
~гемодилюция
}

Когда возникает коронарогенный некроз миокарда: {

=при отрыве атеросклеротической бляшки
~при накоплении аденозина в миокарде
~при выборе катехоламинов
~при гипотиреозе
~при введении антикардинальной цитоксической сыворотки
}

Укажите последствия продолжительного приступа пароксизмальной тахикардии: {

~увеличивается сердечный выброс
~увеличивается коронарный кровоток
=снижается ударный объем сердца
~увеличивается систолическое АД
~увеличивается ударный объем сердца
}

Какие изменения при гипер адреалинемии повреждают миокард? {

~снижение потребления миокардом кислорода
~гипероксигенация миокарда
=снижение доставки кислорода к миокарду
~увеличение эффективности сопряжения аэробного окисления и фосфолирования в кардиомиоцитах
~увеличение содержания АТФ в кардиомиоцитах

}

Какие виды аритмий относятся к монотопным: {

~пароксимальная желудочковая тахикардия

~АВ-ритм (атриовентрикулярный ритм)

~идиовентрикулярный ритм

=синусовая тахикардия

~фибрилляция желудочков

}

Какие виды аритмий относятся к гетеротопным? {

~синдром слабости синусового узла

=желудочковая экстрасистолия

~синусовая брадикардия

~синусовая тахикардия

~синусовая аритмия

}

Укажите причины правожелудочковой недостаточности: {

~артериальная гипертензия большого круга кровообращения

~инфаркт передней стенки левого желудочка

~недостаточность митрального клапана

=гипертензия малого круга кровообращения

~коарктация аорты

}

Укажите причины левожелудочковой недостаточности: {

~гипертензия малого круга кровообращения

~эмфизема легких

=стеноз устья аорты

~Тетрада Фалло

~стеноз легочной артерии

}

Какие проявления характерны для левожелудочковой недостаточности: {

~отеки нижних конечностей

~асцит

=застой в малом кругу

~набухание яремных вен

~гепатомегалия

}

Какие проявления характерны для правожелудочковой недостаточности: {

=застой в системе полых вен

~застой в малом круге

~миогенная дилатация левого предсердия

~повышение А/Д

~все перечисленное

}

Назовите механизмы срочной кардиальной компенсации при сердечной недостаточности: {

~брадикардия

~гипертрофия миокарда

~увеличение ОЦК

=тахикардия

~выброс депонированной крови

}

Каковы методы моделирования артериальной гипертензии в эксперименте: {

~ишемия обоих надпочечников

~перевязка одного мочеточника

~двусторонняя перевязка мочеточников

=ишемизация обеих почек путем стенозирования их артерий

~ишемия одного надпочечника

}

Назовите механизмы срочной экстракардиальной компенсации при сердечной недостаточности: {

~гипертрофия миокарда

~снижение ОЦК

~повышение активности парасимпатической нервной системы

~тоногенная дилатация

=активация ренин-ангиотензиновой системы

}

Назовите причину, оказывающую вазопрессорное действие: {

~ренин

=ангиотензин-2
~гистамин
~серотонин
~агиотензин-1
}

Укажите состояния, сопровождающиеся повышением А/Д: {

~гипотиреоз
~гипокортицизм
~синдром Клайнфельтера
=тиреотоксикоз
~пангипопитуитаризм
}

Увеличение секреции ренина вызывается: {

~увеличением перфузионного давления в артериолах почечных телец
=снижением перфузионного давления в артериолах почечных телец
~гипернатриемией и гипокалиемией
~повышением уровня ангиотензина-2 в крови
~повышенным образованием почками простагландинов
}

Какие изменения возникают в кардиомиоцитах при ишемии в течение 10 минут: {

~снижение сократительной функции
=развитие некроза
~снижение уровня АТФ на 50% от нормального
~начало снижения уровня АТФ
~снижение уровня АТФ на 90% от нормального
}

Какие нарушения функций сердца и центральной гемодинамики возникают при сердечной недостаточности: {

=снижение ударного объема сердца
~повышение ударного объема сердца
~снижение остаточного систолического объема крови в желудочках
~снижение давления крови в сосудах, приносящих кровь к сердцу
~снижение конечного диастолического давления в желудочках сердца
}

Укажите причину цианоза при недостаточности кровообращения: {

- ~повышенное содержание кислорода в крови
 - ~ускорение скорости кровотока
 - =повышение содержания в крови восстановленного гемоглобина
 - ~артериализация венозной крови
 - ~неполное использование кислорода тканями
- }

Какой отдел сердца подвергается гипертрофии при митральном стенозе в стадию компенсации: {

- ~правое предсердие
 - =левое предсердие
 - ~правый желудочек
 - ~левый желудочек
 - ~все перечисленное
- }

О чем свидетельствует появление на ЭКГ отрицательного зубца Т: {

- ~о некрозе миокарда
 - ~о блокаде проведения импульса
 - =об ишемии миокарда
 - ~о проявлении эктопического очага возбуждения в миокарде
 - ~об инфаркте миокарда
- }

Какие гемодинамические изменения характерны для коллапса: {

- ~увеличение ОЦК
 - ~увеличение ударного и минутного объема сердца
 - ~повышение общего периферического сопротивления
 - ~уменьшение емкости сосудистого русла
 - =падение давления в артериях и венах
- }

Какие изменения возникают в крови при синдроме острой сосудистой недостаточности: {

- ~разжижение крови
- =повышение склонности к тромбообразованию
- ~гипокоагуляция

- ~снижение вязкости крови
- ~ускорение кровотока

}

Острое легочное сердце возникает при: {

- ~гипертонической болезни
- ~эмфиземе легких
- ~пневмосклерозе
- =эмболии малого круга кровообращения
- ~все перечисленное

}

Хроническое легочное сердце возникает при: {

- ~эмболии сосудов малого круга
- ~тромбозе сосудов малого круга
- =эмфиземе легких
- ~инфаркте миокарда правого желудочка
- ~инфаркте миокарда левого желудочка

}

Чем характеризуются проявления сердечной недостаточности: {

- =возрастанием конечного диастолического давления
- ~уменьшением остаточного систолического объема крови
- ~понижением давления в венах, по которым кровь притекает к декомпенсированному отделу сердца
- ~брадикардией (60 в 1 мин: {})
- ~все перечисленное

}

Какие изменения в организме возникают при стенозе правого атриовентрикулярного отверстия: {

- ~застой в малом круге кровообращения
- ~брадикардия
- =общий венозный застой
- ~ гипертрофия левого предсердия
- ~повышение давления в малом круге кровообращения

}

Какие вы знаете врожденные пороки сердца синего типа: {

~незаращение овального отверстия предсердной стенки

~незаращение межжелудочковой перегородки

=транспозиция магистральных артерий

~все перечисленное

~коарктация аорты

}

Назовите пороки сердца белого типа: {

~Тетрада Фалло

~транспозиция магистральных артерий

=дефект межпредсердной перегородки

~все перечисленное

~недостаточность клапанов аорты

}

Приведите пример некоронарогенного некроза миокарда: {

~ишемия Принцметала

~тромбоз левой коронарной артерии

=катехоламиновый

~сдавление коронарной артерии при гипертрофии левого желудочка

~все перечисленное

}

Узловой ритм сердца возникает, когда роль водителя ритма берет на себя: {

~эктопические очаги в предсердии

~эктопические очаги в желудочке

=узел Ашоф -Товара

~все перечисленное

~эктопические очаги в пучке Гисса

}

Чем характеризуется предсердная экстрасистолия: {

~увеличением величины зубца Р

=уменьшением величины зубца Р

~углублением зубца Q

~расширением комплекса QRS

~отрицательным зубцом Т

}

Чем характеризуется синоаурикулярная блокада: {

- ~появлением дополнительного зубца Т
 - ~отсутствием зубца Т
 - ~расширением комплекса QRS
 - =выпадением полного сердечного цикла
 - ~выпадением сокращения предсердий
- }

К чему приводит эмболия легочной артерии? {

- ~брадикардия, падение АД
 - =падению АД, полипноэ
 - ~апноэ, асистолия
 - ~снижение венозного давления
 - ~повышение АД
- }

Когда может возникнуть синдром Морганьи - Эдемса – Стокса: {

- ~при синусовой тахикардии
 - ~при одиночной экстрасистолии
 - ~при синусовой брадикардии
 - ~при неполной блокаде
 - =при полной блокаде
- }

Что лежит в основе развития первичной гипотензии? {

- ~нарушение базального тонуса резистивных сосудов
 - =нарушение центральных механизмов регуляции сосудистого тонуса
 - ~повышение сосудорасширяющих веществ
 - ~снижение функции щитовидной железы
 - ~снижение функции надпочечников
- }

Гипертония малого круга связана: {

- ~с тахикардией
- ~с гиперволемией
- ~с централизацией кровотока
- =с митральным стенозом
- ~с правожелудочковой недостаточностью

}

Количество эритроцитов при сердечной недостаточности: {

=увеличивается

~уменьшается

~в стадию компенсации увеличивается, затем падает

~не изменяется

~в стадию компенсации уменьшается, а затем падает

}

Чем характеризуется полная атриовентрикулярная блокада (поперечная)? {

~тахикардией

=диссоциацией сокращений желудочков и предсердий

~брадикардией

~уменьшением силы сердечных сокращений

~выпадением желудочкового комплекса

}

Каковы особенности гетеротропного ритма: {

=неправильный ритм сердцебиений

~брадикардия

~тахикардия

~упорядоченный ритм

}

К чему может привести длительная тахикардия при сердечной недостаточности? {

~к увеличению минутного объема

~к подъему артериального давления

=к нарастанию явлений недостаточности

~к уменьшению утомляемости сердечной мышцы

~к увеличению ударного объема

}

Назовите основной фактор компенсации при митральной недостаточности: {

=левый желудочек

~правый желудочек

~левое предсердие

~правое предсердие
~все перечисленное
}

Чем характеризуется тоногенная дилатация: {
~уменьшением ударного выброса
=увеличением ударного объема
~сочетанием увеличения ударного и уменьшения минутного объемов
~недостаточным освобождением желудочков от крови
~уменьшением систолического крови
}

Какие нарушения кровообращения возникают при мерцании предсердий: {
~ускорение кровотока
~увеличение минутного объема
~повышение артериального давления
=уменьшение минутного объема
~увеличение объема циркулирующей крови
}

Характерные гемодинамические нарушения при травматическом шоке (торпидной фазе): {
=уменьшение объема циркулирующей крови
~увеличение объема циркулирующей крови
~повышение А/Д
~урежение числа сердечных сокращений
~сужение сосудов и увеличение скорости кровотока
}

Как изменяется энергетический обмен сердца при раздражении волокон блуждающего нерва: {
~обмен усиливается
=обмен уменьшается
~обмен извращается
~обмен не изменяется
~все перечисленное
}

Что лежит в основе гипертонической болезни: {

- ~увеличение объема циркулирующей крови
- ~увеличение числа и силы сердечных сокращений
- ~увеличение притока крови в почках
- ~гормонально-активная опухоль надпочечников
- =стойкое повышение тонуса артериол

}

Как можно получить гипертонию растормаживания: {

- ~введением каолина в продолговатый мозг
- =выключением рефлексогенных зон сосудов
- ~раздражением сосудодвигательного центра электрическим током
- ~введением адреналина
- ~нарушением симпатической иннервации сердца

}

Что такое экстрасистолия: {

- ~атипичное распространение возбуждения
- ~нарушение пути прохождения импульса
- =внеочередное сокращение сердца
- ~фибрилляция желудочков
- ~мерцание предсердий

}

Чем характеризуется продольная блокада сердца: {

- ~нарушением проведения импульсов в атриовентрикулярном узле
- ~нарушением проведения импульсов в разветвлениях волокон Пуркинье
- =нарушением проведения импульсов ниже бифуркации пучка Гисса
- ~нарушением проведения импульсов к предсердиям
- ~возникновением диссоциации сокращений предсердий и желудочков

}

Назовите факторы, приводящие к уменьшению объема циркулирующей крови в торпидную фазу шока: {

- ~мобилизация крови в депо
- ~поступление жидкости в сосудистое русло
- ~плазмопотеря
- =депонирование крови
- ~преимущественное скопление крови в малом круге

}

ЭКГ при предсердной экстрасистолии характеризуется: {

=отрицательным зубцом Р, или уменьшением его величины

~отрицательным зубцом Р, который располагается в различных участках комплекса Q R S: {

~компенсаторной паузой вслед за экстрасистолой

~удлинением интервала Р-Q

~тахикарией

}

Какие изменения возникают на ЭКГ при мерцании предсердий? {

=появляются множество мелких волн на месте зубца Р

~уменьшается зубец Р

~удлинняется интервал Р-Q

~возникает внеочередной комплекс

~увеличивается зубец Р

}

Какая фаза сердечной деятельности затруднена при экссудативном перикардите: {

~систола

=диастола

~диастола и систола

~нарушений гемодинамики не наблюдается

}

Что собой представляет кардиогенный шок: {

~нарушение микроциркуляции в тканях

=синдром острой сердечно-сосудистой недостаточности

~нарушение гемодинамики в малом кругу

~снижение периферического сопротивления

~спазм коронарных сосудов

}

ЭКГ при инфаркте миокарда: {

=смещение сегмента ST, изменение QRS и T

~отрицательный зубец Т

~удлинение интервала Р-Q

- ~выпадение желудочкового комплекса
- ~выпадение всего сердечного цикла

}

Какова непосредственная причина ослабления сердечной деятельности при экстрасистолиях: {

- =утомление сердечной мышцы
- ~выпадение сердечного цикла
- ~длинная компенсаторная пауза
- ~внеочередное сокращение
- ~диссоциация работы желудочков

}

Укажите причину повышения давления в полости перикарда: {

- =накопление жидкости в перикарде
- ~сращение перикарда и эпикарда (майка)
- ~небольшие кровоизлияния в полость перикарда при ранении
- ~нарушение диастолического притока крови к сердцу
- ~уменьшение присасывающей силы грудной клетки

}

Проявления синусовой аритмии: {

- ~экстрасистолии синусовые
- ~синусовая тахикардия (увеличение числа сердечных сокращений в 1 мин)
- ~урежение числа сердечных сокращений в 1 мин
- =нарушение последовательности ритма
- ~нарушение проведения импульса

}

В каких случаях развивается динамическая лимфатическая недостаточность: {

- =при сердечной недостаточности
- ~при развитии слоновости
- ~при обтурации лимфатических сосудов
- ~при сдавлении растущей опухолью
- ~все перечисленное

}

Какая форма мерцательной аритмии вызывает наиболее неблагоприятные сдвиги общей гемодинамики: {

- ~тахикардическая форма
 - ~брадикардическая форма
 - ~мерцание предсердий
 - =фибрилляция желудочков
 - ~трепетание предсердий
- }

Чем характеризуется тахикардическая форма мерцательной аритмии: {

- =частым беспорядочным ритмом сокращений желудочков
 - ~сравнительно медленным ритмом сердечных сокращений
 - ~диссоциацией сокращений предсердий и желудочков
 - ~десинхронизацией сокращений желудочков
 - ~чередованием сильного и слабого сокращений сердца
- }

Органические факторы симптоматической гипертонии: {

- =воспалительные заболевания почек
 - ~гиперпродукция вазопрессина
 - ~уменьшение образования АКТГ
 - ~увеличение образования адреналина
 - ~раздражение хеморецепторов при гипоксии
- }

Как меняется скорость кровотока при декомпенсации сердечной недостаточности: {

- ~не изменяется
 - ~увеличивается
 - =уменьшается
 - ~незначительно уменьшается
 - ~незначительно увеличивается
- }

Сущность закона Старлинга: {

- ~увеличение диастолического наполнения к уменьшению ударного объема
- ~уменьшение диастолического наполнения ведет к увеличению ударного объема

=увеличение диастолического наполнения ведет к увеличению ударного объема

~увеличение диастолического наполнения ведет к уменьшению мышечного напряжения желудочков

}

Гемодинамические проявления синусовой брадикардии: {

~увеличение минутного и систолического объема

~ускорение кровотока

~понижение артериального давления

=уменьшение минутного и систолического объема

~уменьшение объема циркулирующей крови

}

Каков механизм возникновения экстрасистол: {

=расстройство нервной регуляции возбудимости сердца и электролитного обмена

~уменьшение концентрации внеклеточного K

~увеличение концентрации Ca в крови

~повышения возбуждения сосудодвигательного центра

~уменьшение концентрации внутриклеточного Ca и K

}

Патологическая синусовая аритмия возникает при: {

=гипоксии головного мозга, травме, нарушении кровообращения

~возбуждении симпатической нервной системы

~торможении сердечных центров блуждающих нервов

~закупорке венечных артерий

~кровоизлияниях в миокарде

}

Какой вид дилатации развивается в

начальный период недостаточности

аортальных клапанов: {

~миогенная дилатация левого желудочка

~миогенная дилатация правого желудочка

=тоногенная дилатация левого желудочка

~тоногенная дилатация правого желудочка

~тоногенная дилатация правого и левого

желудочка

}

Назовите причину кардиогенного шока: {

=инфаркт миокарда

~перикардит

~нарушения проводимости

~экстрасистолия

~стенокардия

}

Периодами Венкебаха-Самойлова

называется: {

=периодическое выпадение на ЭКГ

желудочкового комплекса с последующим
его появлением

~возникновение компенсаторной паузы

после экстрасистолии

~закупорка предсердий

~удлинение интервала Р-Q

~все перечисленное

}

Когда возникает мерцательная аритмия (фибрилляция) предсердия: {

~при нарушении проводимости (блокадах)

~при недостаточности клапанов

=при нарушении возбудимости (экстрасистолиях)

~при резком повышении нагрузки на миокард

~при скоплении жидкости в

перикардальной полости

}

Укажите последствия нарушения микроциркуляции при кардиогенном шоке: {

=нарушение метаболизма тканей и ацидоз

~перераспределение крови

~скопление крови в капиллярах и повышение давления

~внутрисосудистая агрегация эритроцитов

~уменьшение диастолического притока крови к сердцу

}

Каков механизм почечной гипертензии: {

~увеличение систолического давления

=усиление образования ренина (ангиотензина) и спазм артерий

~усиление образования адреналина в надпочечниках

~нарушение венозного оттока от почек

~изменение физико-химических свойств стенки сосудов

}

Как изменяется работа правого желудочка при митральном стенозе в фазе компенсации: {

~снижается

=не изменяется

~резко снижается

~увеличивается

~резко увеличивается

}

Какие виды экстрасистол встречаются чаще всего: {

~синусовые

=предсердные

~атриовентрикулярные из верхней части АВ-узла

~желудочковые

~атриовентрикулярные из нижней части АВ-узла

}

Какой вид клапанного порока встречается наиболее часто: {

~недостаточность устья аорты

~стеноз устья аорты

=недостаточность двустворчатого клапана

~сужение левого атриовентрикулярного отверстия

~все перечисленное

}

Какие нарушения кровообращения возникают при мерцании предсердий: {

~ускорение кровотока

~увеличение минутного объема
~повышение А/Д
=уменьшение минутного объема
~увеличение ОЦК
}